32. L'APPARATO GENITALE INFERIORE

DURATA : 08:54 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video immersivo sull'Apparato Genitale Inferiore, esploriamo l'embriologia della vagina e dell'utero, evidenziando la dinamica di crescita posteriore che forma queste strutture essenziali. L'equilibrio ginecologico viene affrontato attraverso l'analisi dei movimenti tra il sacro e il peritoneo, e come queste interazioni influenzano la salute degli organi riproduttivi. Concentrandosi su squilibri come aborti spontanei o endometriosi, il video propone affascinanti tecniche terapeutiche basate su concetti di pulizia energetica, equilibrio fasciale e legami transgenerazionali. Questo approccio permette ai praticanti di imparare a

L'APPARATO GENITALE INFERIORE: APPROCCIO BIODINAMICO

EMBRIOLOGIA DELLA VAGINA E DELL'UTERO

L'inserimento della **vescica** a livello del **tubercolo di Müller**, situato nel seno urogenitale, è essenziale. Questa zona comprende la vescica, l'uretra e l'attacco a livello della vagina.

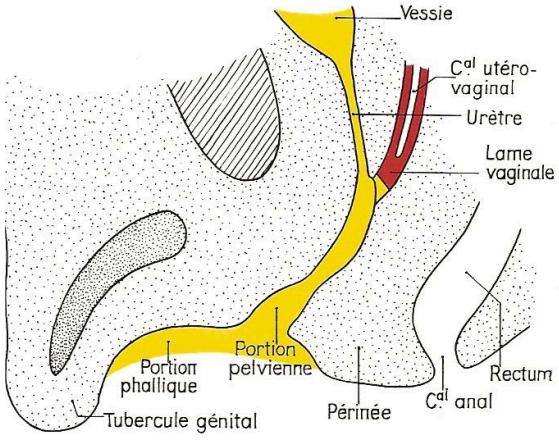


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

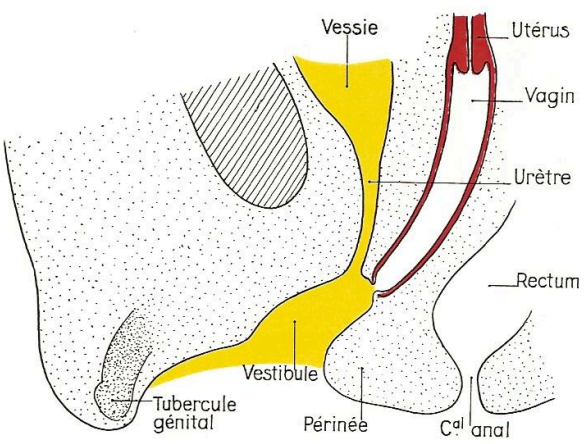


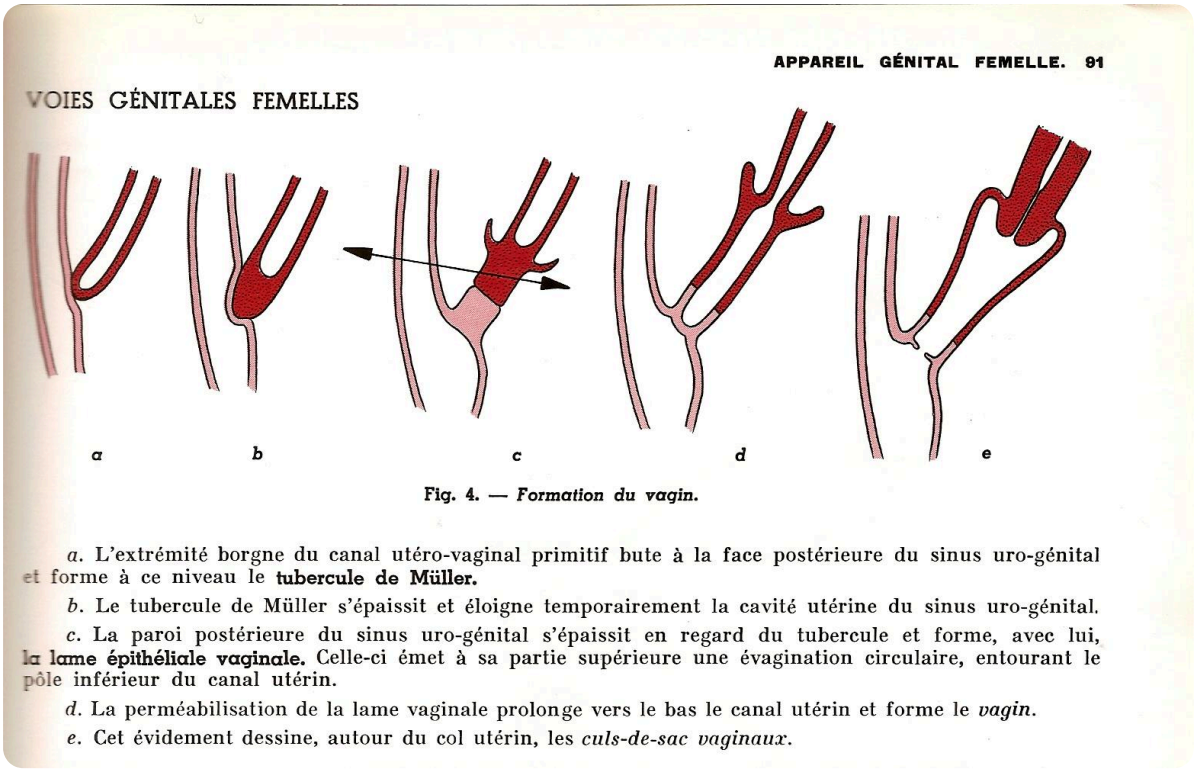
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Sviluppo tratto urogenitale femminile

La vagina deriva dal **mesoderma**, specificamente dal canale di Müller. La formazione delle **lamine vaginali** è il risultato della crescita posteriore del sacro e del tubo neurale.

La velocità di crescita differenziale di questa parte posteriore crea lo spazio di apertura della vagina. È il movimento **postero-anteriore**, tra il rene e il sacro, che permette questa estensione.

Il tubercolo di Müller si ispessisce e poi viene stirato, non da una trazione superficiale, ma dalla spinta più rapida della parte posteriore. Questo fenomeno porta all'allungamento e alla formazione della vagina e del collo dell'utero.



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

FIG. — Vaginogenesi

La parete posteriore del seno urogenitale si ispessisce, dando origine alle lamine vaginali che si aprono e si stirano. Questa dinamica è simile, con la parte posteriore che cresce più rapidamente.

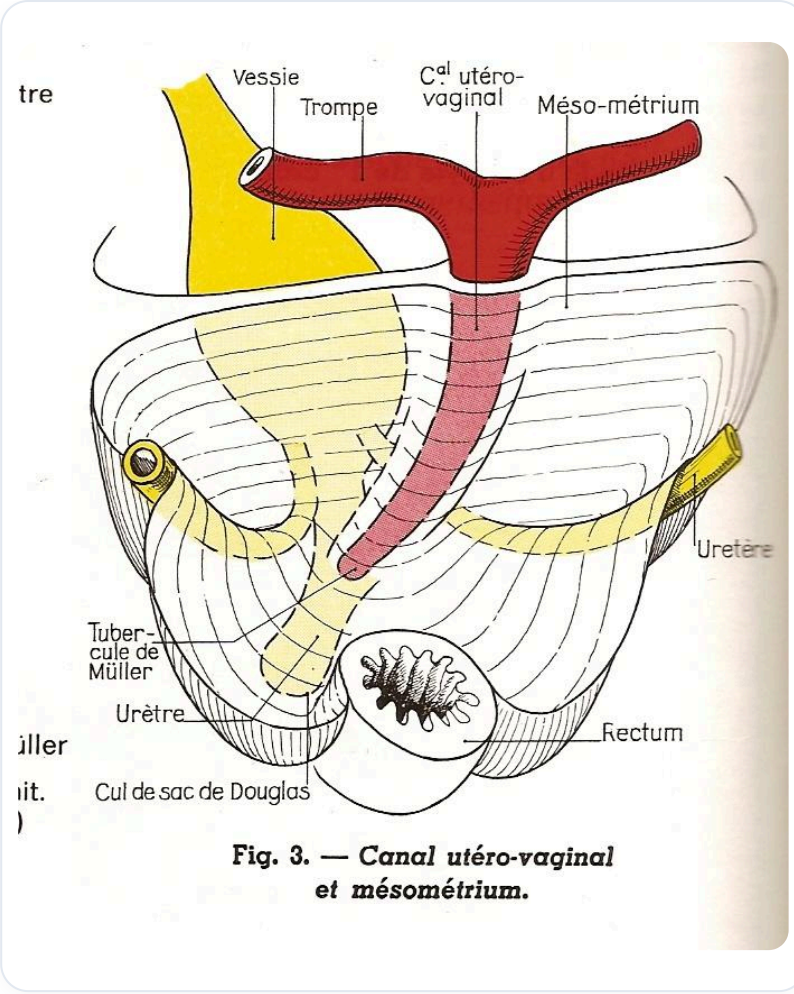


FIG. — Canale utero-vaginale

EQUILIBRIO GINECOLOGICO E MOVIMENTO BIODINAMICO

Durante l'esame dell'utero, si percepisce un movimento tra il **sacro** e il **peritoneo**. È nell'interazione di questi due poli che si trovano l'equilibrio vaginale e uterino.

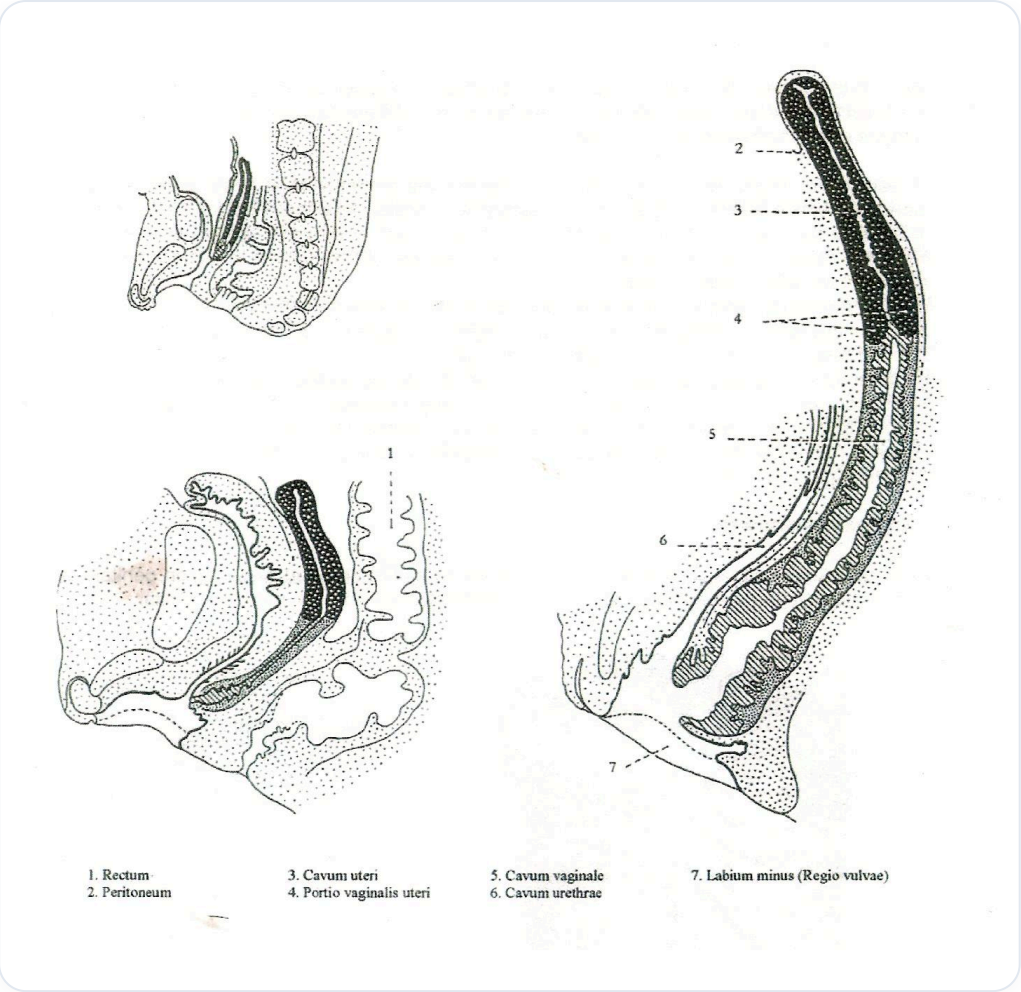


FIG. — Anatomia uterina femminile

A livello gonadico, un movimento inverso si avverte a livello del ventre, seguendo il legamento in direzione del pube, come un'onda che scende.

La discesa del sacro è influenzata dal tubo neurale. Un altro punto di appoggio cruciale è la combinazione del pube e del sacro, che forma un equilibrio fasciale essenziale del piccolo bacino nella donna.

Questo equilibrio implica una linea di forza discendente relativa al sacro, influenzando diverse funzioni del corpo femminile.

APPROCCIO TERAPEUTICO AGLI SQUILIBRI UTERINI

Situazioni come gli **aborti spontanei** lasciano un'impronta energetica nell'utero. Una pulizia energetica dell'utero diventa quindi necessaria.

Possiamo approcciare l'utero con una **forza magnetica**, imparando a sentire il campo energetico a distanza. Il praticante percepisce una frequenza, una zona di calore che si densifica, segno dell'energia presente.

Il mio approccio consiste nello "scannerizzare" e identificare le zone che necessitano di una pulizia. Si tratta di ridare libertà ai tessuti e alle energie.

Una **retroversione uterina**, per esempio, può causare fasi congestizie. Il lavoro a distanza mira a riequilibrare il sistema ginecologico, in stretto legame con la **gastrina**.

L'**endometriosi**, caratterizzata da una proliferazione di tessuto che risale nel peritoneo, è spesso associata a dolori lombari e sacro-iliaci.

LA CAVITÀ INTRAPERITONEALE E LA DIMENSIONE TRANSGENERAZIONALE

Nella donna, esiste un legame diretto tra il collo dell'utero, le tube e la **cavità intraperitoneale**. Questa cavità è di grande importanza, percepita come un "cielo" o uno spazio primordiale.

Ogni stato del corpo rappresenta la migliore risposta funzionale possibile in un dato momento. Questa risposta è influenzata dalla nostra vita, ma anche da quella dei nostri antenati.

Una retroversione uterina, per esempio, può essere la migliore risposta che il corpo ha trovato per risolvere un problema **transgenerazionale** o personale profondo.

È essenziale comprendere perché uno schema transgenerazionale si manifesta in questo modo. La terapia mira a decodificare questa "migliore risposta" e a offrire la liberazione necessaria, se richiesta.

L'embrione illustra perfettamente questa nozione: ad ogni stadio di sviluppo, presenta la migliore risposta fisiologica possibile.

LA NEURULAZIONE SECONDARIA E LA FORMAZIONE DEL FILUM TERMINALE

Il **tubo neurale** è associato a un'eminenza caudale posteriore, creando uno spazio di luce e di connessione. Si osserva il germoglio caudale e la parte terminale della **notocorda**.

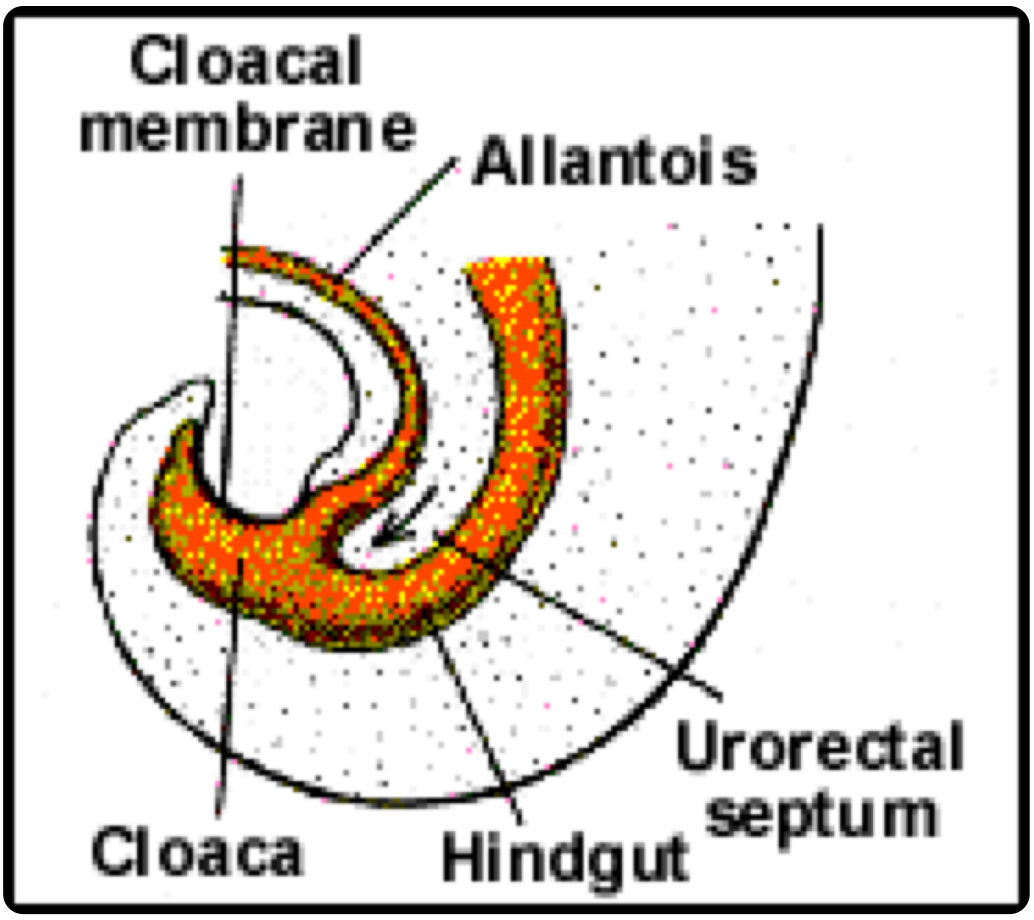


FIG. — Sviluppo cloacale embrionale

Lo spazio del retto e il tubo neurale con il neuroporo posteriore sono in stretta relazione. Una connessione si forma grazie a un movimento di sviluppo più pronunciato nella parte posteriore.

Questa implica una chiusura e poi una riapertura per stabilire questa connessione. Questo processo porta all'emergere del neuroporo posteriore e all'allungamento per formare il **filum terminale**.

Questo è ciò che viene chiamato **neurulazione secondaria**. La manipolazione del sacro rivela queste velocità di crescita differenziali, dove la giunzione iniziale si allunga posteriormente.

L'integrazione dell'eminenza caudale assicura la continuità con il tubo neurale, formando questa neurulazione secondaria ascendente.

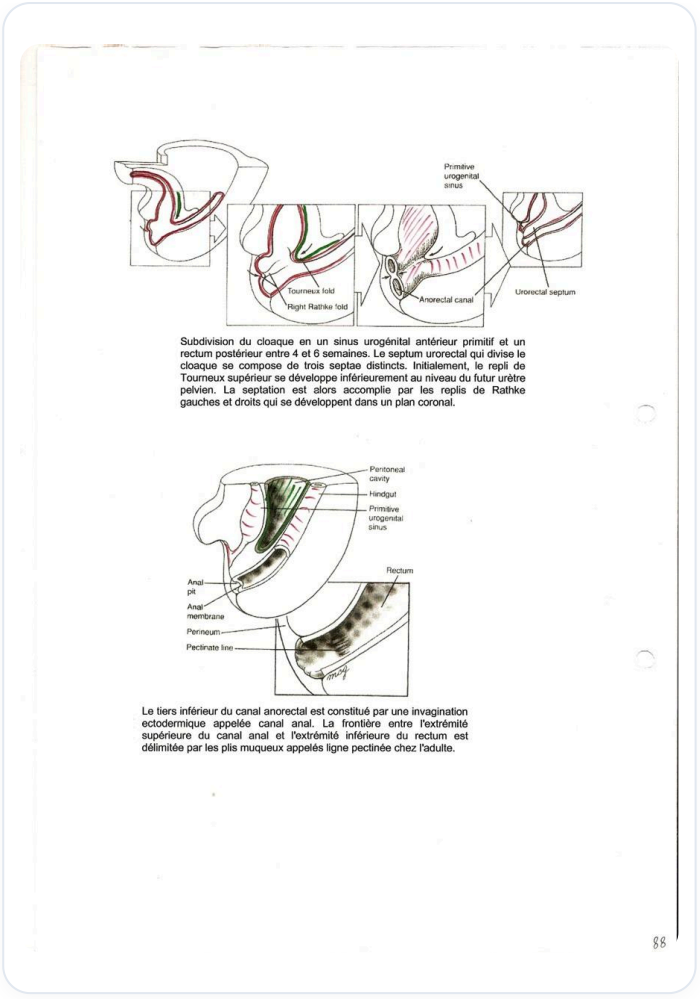


FIG. — Settazione della cloaca

SVILUPPO DEL PERINEO E INFLUENZA EPATICA

A livello del **perineo**, osserviamo l'emergere degli arti inferiori e una trazione che si esercita. Questo movimento è profondamente legato al sistema uterino.

La basculazione del **fegato**, in sinergia con la discesa del tubo neurale e del sacro, influenza il movimento di sviluppo che tira verso la linea alba, tramite il legamento falciforme.

Questo sviluppo epatico provoca una basculazione che interessa l'intera zona uterina in sviluppo. Potrebbe spiegare fenomeni di migrazione o di trazioni differenziali legate alla posizione uterina.

Un legamento si sviluppa tra il pube e l'ombelico, incapsulando la storia della discesa e della formazione uterina.

Come lo sterno contiene la storia della nostra flessione, questo legamento ventromediale (sulla linea alba) concentra la storia di tutta la formazione posteriore, della **gonadizzazione** e dell'**uterizzazione** del bacino.

La linea alba è l'incontro di tutta la storia **urogenitale**.